ONEMA-POP-051 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

Suspeita de Migração ou Mau Posicionamento de Cateter Central —

PICC/Port-a-Cath

1. Identificação institucional

2. Objetivo e abrangência

Padronizar avaliação, decisão, execução e comunicação no contexto de suspeita de migração ou mau posicionamento de

cateter central — picc/port-a-cath, em atendimento domiciliar presencial ou remoto conforme aplicabilidade. Não substitui

prescrição, avaliação médica nem instruções do fabricante.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e capacitado; executar intervenções apenas no âmbito legal, da prescrição e do protocolo institucional.

Não realizar manipulação invasiva quando não houver indicação, treinamento, material adequado ou estabilidade clínica.

4. Materiais e fornecimento

EPIs, dispositivo de pressão e oximetria, documentação de comprimento externo prévio e curativo estéril se indicado.

Equipamentos profissionais/EPIs: enfermeiro ONEMA; consumíveis específicos: paciente/responsável, salvo ajuste

contratual. Em visita presencial, equipamentos de avaliação clínica conforme indicação.

5. Avaliação e preparo

Comparar comprimento externo, integridade da fixação, dor, edema, refluxo e posição anterior documentada. Confirmar

identificação, consentimento, alergias, medicamentos, ambiente, suporte disponível e condições para encaminhamento.

6. Execução técnica numerada

01. Confirmar identificação, tipo do cateter e indicação da terapia em curso.

02. Interromper qualquer infusão se houver suspeita de migração ou mau posicionamento; não testar por infusão.

03. Inspecionar sem tracionar: fixação, segmento externo, edema cervical/torácico, dor, desconforto respiratório.

04. Comparar marcação externa e registros prévios; não inferir posição da ponta apenas pelo aspecto externo.

05. Não avançar, recuar, reposicionar ou utilizar o cateter por tentativa.

06. Comunicar imediatamente prescritor/equipe vascular para confirmação de posicionamento por método indicado.

07. Se dispneia, dor torácica, arritmia, síncope ou deterioração, acionar SAMU 192.

08. Registrar suspensão, avaliação, comunicação e destino; identificar cateter como não utilizável até liberação formal.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Sintomas cardiopulmonares ou migração significativa: emergência; não utilizar até confirmação e autorização. Na emergência, acionar SAMU 192 e registrar o horário. Não insistir em procedimento inseguro.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar a não manipular a fixação; plano de avaliação e acesso alternativo definido pela equipe.

9. Carteira Digital ONEMA

Registrar data/hora, modalidade, identificação e consentimento, achados positivos e negativos, sinais vitais se pertinentes,

intervenção passo a passo, materiais/dispositivo quando aplicável, intercorrências, comunicação, encaminhamento,

orientações, plano de seguimento e identificação profissional.

10. Referências técnicas rastreáveis

CDC catheter guidelines; INS Infusion Therapy Standards (2024), edição licenciada | Conferir aplicação integral ao cenário

brasileiro e IFU específico antes de liberação assistencial.

aplicativo.